

23 - 03- Les pancréatites aiguës - Pr. Narjis

Le cours que nous allons entamer aujourd'hui s'intitule les pancréatites aiguës. Ce cours fait partie du module pathologie digestive chirurgicale destiné aux étudiants de troisième année des études médicales. Présenté par moi-même, le professeur Youssef Najis, professeur de l'enseignement supérieur en chirurgie générale et digestive à l'hôpital Buntofeil de Marrakech.

En guise d'introduction, que pouvons-nous dire par rapport à la pancréatite aiguë? Pour définition, la pancréatite aiguë se définit comme une inflammation aiguë du pancréas. C'est une urgence à la fois médicale et chirurgicale. C'est une urgence médico-chirurgicale faisant intervenir plusieurs spécialités au fait du chirurgien, du gastroenterologue, de la radiologue, éventuellement de la réanimateur.

Et donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire de cette pathologie. C'est une pathologie qui reste fréquente. C'est une complication fréquente, surtout dans notre contexte de la lithiase biliaire.

Et donc, l'étiologie biliaire reste la première cause des pancréatites aiguës par rapport à d'autres pays. Nous allons le revoir en épidémiologie. Les causes varient en fonction du profil épidémiologique de cette pathologie.

Le diagnostic, il est évoqué cliniquement pour une douleur qui est assez caractéristique, dont on verra un petit peu les différents symptômes, les différents signes lorsqu'on parlera du diagnostic positif. Et il est confirmé par la biologie. Nous verrons qu'il y a donc quelques examens biologiques à demander qui sont assez simples, assez rapides à obtenir, qui peuvent nous conduire rapidement vers le diagnostic.

Il faut retenir déjà à ce stade qu'il existe deux grands types, deux grandes variétés de pancréatites aiguës. Les pancréatites aiguës dites bénignes, qui n'ont pas de complications, qui n'engagent pas le pronostic vital du patient. Et à côté, nous avons des pancréatites aiguës graves qui peuvent entamer le pronostic vital du patient.

Le plan que nous allons suivre pour traiter cette question, après avoir vu ensemble l'introduction, nous verrons les rappels, le rappel anatomique, puis le rappel physiologique. Nous aborderons par la suite ce qui est épidémiologie de cette pathologie, la pancréatite aiguë. Nous verrons les mécanismes physiopathologiques responsables de la pancréatite aiguë.

Nous aborderons ensuite les différents volets anatomiques pathologiques de la pancréatite aiguë. Nous parlons du diagnostic. Vous allez voir qu'il y a plusieurs rubriques dans le diagnostic.

Nous verrons ensuite l'évolution et les complications possibles de cette pathologie. Nous verrons ensuite les grands volets thérapeutiques et nous concluons. Commençons tout d'abord par les rappels.

Le premier rappel est le rappel anatomique. Pour rappel anatomique, le pancréas ou pancréas, c'est la même chose. C'est une glande annexe du subjectif.

C'est une glande qui est située de façon profonde dans la cavité abdominale. C'est une glande qui est rétro-péritoniale. Pour rappel anatomique, c'est une glande qui est située derrière le péritone pariétal postérieur.

C'est une glande qui va se projeter dans la région épigastrique. Ça sous-entend qu'à chaque fois que cet organe sera malade, à chaque fois que cet organe sera atteint, c'est dans la région épigastrique que le patient ressentira la douleur. C'est une notion qui est très importante.

C'est un organe qui a des connexions très importantes, notamment avec le duodenum, dans lequel il est quasiment enchâssé d'une part, et également et surtout avec les voies biliaires. Pour rappel anatomique, le canal colédoque va se réunir avec le canal du versongue pour se jeter ensemble dans l'ampoule de vataire. Ces deux canaux sont communicants et ça expliquera pas mal de choses sur le plan pathologique.

Si vous avez par exemple un calcul biliaire qui va bloquer l'ampoule de vataire, forcément qu'il va bloquer à la fois le canal colédoque et également le canal du versongue. Ça explique que si on a une pathologie biliaire, nous pouvons également avoir un problème pancréatique. C'est une notion anatomique qui est très importante.

Maintenant, sur le plan physiologique, le pancréas est une glande mixte. Donc, c'est une glande à la fois endocrine, intervenant directement dans la régulation de la glycémie par la sécrétion de l'insuline et du glucagon, en régulant la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et également, c'est une glande exocrine.

Donc, c'est une glande qui va produire ce qu'on appelle le sucre pancréatique. Ce sucre pancréatique qui sera déversé par les canalicules pancréatiques dans les deux canaux principaux, le canal de Santorini et le canal de Viersong, qui vont se jeter dans le duodénum pour permettre la digestion des lipides, du glucide et des protéines grâce à un système enzymatique assez complexe. Maintenant, sur le plan épidémiologique de la pancréatite aiguë, c'est une pathologie qui reste très fréquente.

Donc, dans notre service, par exemple, il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons quasiment 3, 4, 5 pancréatites hospitalisées. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente, surtout dans notre contexte. Et ce sont souvent des femmes, donc ce sont des femmes d'un âge adulte, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui vont souffrir de cette pathologie.

Dans notre contexte, la cause principale, et c'est une notion qui est très importante. Donc, si par exemple, on vous pose la question, quelle est la cause la plus fréquente des pancréatites aiguës au Maroc, dans notre contexte, eh bien, c'est la lithiase biliaire. Par rapport à d'autres écrits, si vous vous amusez à aller sur Internet, vous voir des publications françaises, américaines,

japonaises, que sais-je, donc vous allez voir que c'est différent.

Vous allez voir que la pathologie alcoolique ou l'alcoolisme est la première cause des pancréatites aiguës dans certains pays. Mais dans notre contexte, l'éthiologie biliaire, notamment la lithiase biliaire, est la cause la plus fréquente des pancréatites aiguës. À côté de ces deux grandes étiologies que sont la pathologie lithiasique biliaire et l'alcoolisme, nous avons également d'autres étiologies qui sont beaucoup plus rares, mais qui doivent être recherchées lorsqu'on n'a pas de cause qui est évidente pour la pancréatite aiguë, notamment les maladies de système et notamment le lupus, les hypercalcémies, les hyperparathyroïdes, et puis également une petite parenthèse par rapport à ce qu'on appelle les pancréatites iatrogènes.

Ce sont des pancréatites qui vont être provoquées par un geste thérapeutique ou un geste diagnostique. Donc, si vous faites, par exemple, une fibroscopie indigestive haute, vous allez introduire d'autres fibroscopes qui vont traverser l'œsophage, l'estomac, le duodenum, et parfois le gastroentérologue va réaliser un geste sur ce qu'on appelle la papille, sur l'ampoule de Vater, il va faire ce qu'on appelle une sphinctérotomie. Et en réalisant cette sphinctérotomie, il peut inflammer le canal de Wirsung et en inflammant le canal de Wirsung, on peut avoir ce qu'on appelle une pancréatite aiguë iatrogène, une pancréatite aiguë post-thérapeutique.

Donc, elle est provoquée par le geste thérapeutique ou diagnostique fait par le corps médical. Également, d'autres causes qui sont plus rares, les causes médicamenteuses, certains médicaments sont connus pour être pourvoyeurs de pancréatite aiguë, même si c'est extrêmement rare. Et puis, également, les hyperlipidémies.

Donc, nous voyons très bien que c'est une grande panoplie de causes, d'étiologies qui peuvent entraîner une pancréatite aiguë. Mais dans notre contexte, comme je le dis et je le répète, c'est la pathologie lithiasique biliaire qui reste la première cause. Voilà, dans notre contexte, pour résumer ce qui est épidémiologie, le plus souvent, c'est une femme qui a entre 30 et 50 ans, qui rapporte la notion de colique hépatique ou qui a été opérée pour une lithiase biliaire ou qui a des antécédents de chirurgie biliaire ou de sphinctérotomie dans les antécédents et qui va commencer à rapporter cette douleur épigastrique.

Donc, dans ce contexte là, pensez à une pancréatite aiguë. Mettons sur le plan physiopathologique. Sur le plan physiopathologique, il y a ce qu'on appelle des mécanismes initiateurs.

Les mécanismes initiateurs, qui sont les plus fréquents, la lithiase dans notre contexte, l'alcoolisme ailleurs et rarement les médicaments, ces mécanismes initiateurs vont perturber le fonctionnement des enzymes au sein de la glande pancréatique. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont entraîner une activation des enzymes au sein des canaux pancréatiques. Donc, les enzymes sont déjà actives au sein du pancréas et comme les enzymes sont extrêmement agressives, elles vont commencer à attaquer le parenchyme du pancréas.

Elles vont produire ce qu'on appelle une autodigestion du pancréas et donc le pancréas va s'inflammer en réaction à cette autoagression, à cette autodigestion par les enzymes qui sont actives au sein du pancréas. Cela aura pour conséquence deux types de complications possibles. Le pancréas sera inflammé, sera brûlé.

Donc, nous aurons ce qu'on appelle les lésions localisées à la glande pancréatique. D'une part, ce sont les complications locales et d'autre part, nous pouvons avoir des phénomènes inflammatoires généralisés. Ces phénomènes généralisés sont beaucoup plus graves.

Elles sont observées lorsqu'on a affaire à des pancréatides aigus graves. Donc, non seulement nous allons avoir une atteinte de la glande pancréatique, mais nous aurons également une perturbation du métabolisme général du corps humain avec des réactions inflammatoires qui sont très accentuées et qui peuvent parfois malheureusement engager le pronostic vital quasiment du patient. Mettons sur le plan anatomopathologique, une grande distinction.

Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Une grande classification qui est très importante à connaître. D'une part, vous avez les pancréatides aigus oedémateuses, dites bénines.

Ce sont des pancréatides aigus où on a juste de l'œdème, donc une augmentation de la taille du pancréas, éventuellement une infiltration de la glande pancréatique, mais qui reste localisée à la glande pancréatique. Donc, c'est une inflammation qui est bénine, qui n'est pas grave, qui souvent va régresser, comme on va le voir dans le chapitre des complications, qui va régresser le plus souvent sans avoir de complications. À côté de cette entité oedémateuse bénine, nous avons une entité extrêmement grave qu'on appelle la pancréatide aiguë nécrotico-hémorragique.

Donc là, on n'a plus seulement de l'œdème, mais on a de la nécrose et on a de l'hémorragie au sein de la glande pancréatique. Et donc là, on va avoir à la fois une atteinte, une destruction massive de la glande pancréatique. Et puis, à côté également, on peut avoir des complications d'ordre général, d'ordre métabolique général, qui peuvent engager le pronostic vital du patient.

Donc, pour résumer, sur le plan anatomopathologique, deux grandes entités, la pancréatide oedémateuse bénine sans complication et la pancréatite nécrotico-hémorragique grave, pouvant même entraîner le pronostic ou engager le pronostic vital du patient. Alors maintenant, une question se pose. Vous, en tant que futur praticien, en tant que futur médecin, une question va se poser à vous.

Comment prendre en charge une pancréatide aiguë? Quelles sont les étapes pour prendre en charge une pancréatide aiguë? Si je pense à une pancréatide aiguë, j'ai une dame qui constate, je suis le garde aux urgences, quand je vais penser à la pancréatide aiguë, comment je vais prendre en charge cette pancréatide aiguë? Donc là, dans votre tête, dans votre façon de raisonner, vous allez suivre trois étapes principales dans la prise en charge d'une pancréatide aiguë. Tout d'abord, s'agit-il vraiment d'une pancréatide aiguë? C'est-à-dire, il faut poser le

diagnostic positif de la pancréatite aiguë. Comment le poser? On va le voir.

C'est très, très simple. Donc, première question à se poser. S'agit-il vraiment d'une pancréatite aiguë ou bien s'agit-il d'une autre pathologie? Donc, ça, c'est un.

Deuxième question. Maintenant, je sais que c'est une pancréatite aiguë. Est-ce que c'est une pancréatite aiguë qui est grave, qui peut engager le pronostic vital du patient, ou bien est-ce que c'est une pancréatite aiguë oedémateuse, bénigne, simple à surveiller, qui va régresser au bout d'un certain moment? Donc, deuxième question.

Troisième question. Il faut rechercher une cause de la pancréatite aiguë. Donc, si je ne traite pas la cause de la pancréatite aiguë, le risque, c'est que le patient, même si elle est guérie, elle peut refaire une nouvelle fois une pancréatite aiguë.

Tant que la cause, elle est là, elle peut refaire une pancréatite aiguë. Et donc, troisième question qu'il faudra se poser, c'est quelle est la cause de la pancréatite aiguë? Question très importante. Donc, pour récapituler, quelles sont les trois étapes à suivre? Première étape, je pose les diagnostics positifs.

Deuxième étape, j'évalue la gravité de la pancréatite aiguë. Et troisième étape, je cherche la cause de la pancréatite aiguë. Mais tout ceci, il ne faut pas oublier que vous êtes face à un patient, vous êtes de garde, vous êtes aux urgences, vous êtes praticien.

Et donc, vous êtes face à un patient. Le patient, s'il a qu'une cité, c'est qu'il a une souffrance, le patient. Et donc, première des choses, en faisant tout cela, tout ce schéma de raisonnement dans votre tête, n'oubliez pas de soulager le patient.

Le patient, quand il va venir, vous pensez à ces trois étapes principales, mais vous prenez une voie veineuse, vous donnez des antalgiques, vous soulagez le patient. Donc, c'est très important. Pensez tout d'abord au patient et, bien sûr, raisonnez dans votre tête en tant que praticien.

Bien, donc, première étape, comme on a dit, le diagnostic positif. Comment peut-on poser ou comment peut-on penser déjà une pancréatite aiguë? Alors maintenant, le patient, quel est le signe clinique qui va faire que le patient va venir vous consulter? Quel est le principal signe clinique? Ce qu'on appelle le maître symptôme, parce qu'il y a toujours un symptôme qui amène le patient à consulter. En matière de pancréatite aiguë, le maître symptôme est la douleur abdominale.

Cette douleur abdominale, elle a certes certaines caractéristiques qui sont typiques. On verra par la suite. Mais vous, en tant que praticien, il faut toujours penser à la pancréatite aiguë parce qu'on a parfois des formes qui sont atypiques, des formes qui n'ont pas le tableau complet de pancréatite aiguë.

Et donc, ayez ce réflexe-là de penser devant toute douleur abdominale aiguë à une pancréatite

aiguë. Chaque fois que vous avez un patient qui consulte en urgence pour douleur abdominale aiguë, pensez à une pancréatite aiguë. Alors maintenant, quels sont les signes classiques qu'on a cités? Le tableau complet, le tableau le plus caractéristique d'une pancréatite aiguë.

Tout d'abord, le siège de la douleur. La douleur est épigastrique. C'est une douleur qui va s'installer de façon brutale.

C'est une douleur brutale aiguë et surtout, c'est une irradiation postérieure. Donc, c'est une irradiation postérieure. C'est ce qu'on appelle une douleur transfixiante.

Le patient, c'est comme s'il recevait quasiment un coup de couteau dans la région épigastrique et comme si le couteau s'enfonçait vers son dos, vers la région postérieure de l'abdomen. Donc, c'est ce qu'on appelle une douleur transfixiante, une douleur irradiation postérieure. C'est une douleur qui est très intense, donc l'intensité, elle est très importante de la douleur.

Donc, vous connaissez bien sur l'échelle de la douleur de zéro à dix que vous pouvez donc demander à votre patient. Donc souvent, c'est une douleur qui est très, très haute dans l'échelle de la douleur, très intense. Autre chose très importante, c'est que la douleur n'est pas paroxystique.

C'est une douleur qui est continue. C'est très important. Les douleurs paroxystiques sont souvent des douleurs qui sont dues à des spasmes musculaires, notamment ce qu'on appelle par exemple dans la colique hépatique qui est due au spasme, aux contractions de l'arbre biliaire, la colique néphritique qui est due également au spasme de l'urètre ou des voies urinaires face à un obstacle.

L'occlusion intestinale est également due au spasme intestinal. Donc là, c'est une douleur qui est continue. Pourquoi? Parce que vous avez une inflammation qui est installée et donc l'inflammation, elle est là, elle est installée.

Et donc, forcément, la douleur sera continue. Si vous demandez la question au patient, le patient vous dira que c'est une douleur qui est tout le temps là, qui est tout le temps présente. Autre signe caractéristique, c'est la position entalgique.

Donc, le patient, lorsqu'il a une douleur, bien sûr, il cherche toujours une position pour calmer sa douleur, ce qu'on appelle la position entalgique. Et en matière de pancréasite aiguë, la douleur qui va un petit peu calmer l'intensité de cette pancréasite aiguë, c'est la position antéfléchie. Donc, le patient viendra aux urgences dans une position typique.

C'est un patient qui tient la région épigastrique entre ses deux mains et qui est penché en avant. Donc, c'est un patient en position antéfléchie, en position de chien de fusil, d'accord? Éventuellement, le facteur déclenchant, c'est après un repas abondant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange, les glandes annexes au tube digestif, notamment la glande pancréasie, va

commencer à sécréter son sucre pancréatique.

Et c'est ce sucre pancréatique qui va faire que la douleur va apparaître. Les autres signes, ils sont variables, ils ne sont pas constants. On peut avoir des nausées, on peut avoir des vomissements.

On peut même avoir une occlusion fonctionnelle, ce qu'on appelle un lilius paralytique. Donc, la glande pancréatique est inflammée et comme elle est inflammée, elle va entraîner un blocage des contractions musculaires. Et donc, le patient peut consulter avec une véritable occlusion, une occlusion fonctionnelle.

Les signes généraux maintenant, les signes généraux, ils sont variables. Là aussi, ils vont dépendre de la gravité. Si vous avez une pancréatite qui est oedémateuse, qui est bénigne, ils sont quasiment inexistantes, ces signes généraux.

Par contre, si vous avez une pancréatite grave, une pancréatite sévère, là, vous pouvez avoir des signes généraux qui sont plus ou moins graves. Vous pouvez avoir un pot qui est rapide, qui est filant au début. Vous pouvez commencer à avoir des signes, des stigmates d'hypotension artérielle.

Vous pouvez même avoir un patient qui est en état de choc. Dans des pancréatites qui sont sévères, qui sont très graves, le patient peut consulter dans un état de choc. Et donc, c'est ce qui fait que la pancréatite aiguë peut, heureusement, elle est souvent bénigne, mais peut être très, très grave dans certaines situations.

La fièvre également, elle est inconstante en matière de pancréatite aiguë. Alors, ce qui est important en matière de pancréatite aiguë, sur le plan clinique, c'est qu'il y a une grande discordance. Vous avez un patient qui a une douleur très importante, très intense, qui est quasiment fléchue en avant.

Mais lorsque vous déshabillez le patient, lorsque vous voulez examiner le patient, vous allez voir un examen le plus souvent. Je dis bien le plus souvent, qui est pauvre, qui est quasiment normal. On voit une petite sensibilité de la région épigastrique, on peut avoir un météorisme épigastrique, on peut avoir une défense épigastrique, mais qui est extrêmement rare.

Mais souvent, on a cette fameuse discordance entre une douleur abdominale qui est très intense, d'une part, et un examen clinique qui est pauvre, quasiment. On peut avoir également des signes qui sont historiques. Vous allez revoir dans certains bouquins que vous pouvez voir sur Internet, ce qu'on appelle l'équimose des flancs, le signe de Grey Turner, ou l'équimose péri-ombilicale, le signe de Kullen.

Voilà donc, signe de Grey Turner, l'équimose des flancs, et puis l'équimose péri-ombilicale, le signe de Kullen. Ce sont des signes qui sont historiques, qui sont rarement retrouvés chez les

patients. Donc, en pratique, il faut retenir ça.

La discrétion des signes physiques contraste avec l'importance des signes fonctionnels. Et donc, cette dissociation, cette discordance entre signes physiques peu importants et signes fonctionnels très importants, doit faire penser à la pancréasite aiguë. Elle est assez caractéristique de la pancréasite aiguë.

Voilà donc, au total, la deuxième question que vous allez vous poser en tant que praticien, donc vous avez une douleur épigastrique transfixante aiguë. Je pense très intensément dans ma tête à la pancréasite aiguë. Que dois-je faire ? Quel bilan dois-je demander en urgence ? Qu'est-ce qui se passe ? Le bilan complémentaire, il se résume quasiment à une ou deux lignes.

C'est le dosage de la lipasémie. Retenez ça une fois pour toutes. Donc, si je vous pose la question, quel est l'examen complémentaire que vous allez demander chez un patient sur lequel vous pensez à une pancréasite aiguë ? Ne cochez rien, cochez juste la lipasémie.

Donc, lipasémie, c'est le bilan sanguin à demander. C'est un bilan qui est rapide, qu'on va voir très, très vite. La mylasémie, je l'ai mise, mais sans mettre de croix dessus, parce que dans certaines régions reculées, dans certains laboratoires, on n'a pas la lipasémie.

On n'a pas encore la lipasémie. On a la mylasémie, qui peut également confirmer le diagnostic, mais retenez surtout la lipasémie. Donc, la lipasémie, elle est à doser dans les 48 heures suivant le début des symptômes.

Pour parler de pancréasite aiguë, retenez ça, c'est très, très simple. Vous devez avoir une valeur à trois fois la normale. Donc, lorsque vous prenez le résultat de votre laboratoire, vous avez ce qu'on appelle le seuil normal.

Le seuil normal, le plus souvent, pour une lipasémie normale, c'est en dessous de 60 unités par litre. Donc, pour retenir le diagnostic de pancréasite aiguë, il faut avoir un seuil qui est supérieur à 180. Donc, trois fois 60, 180, plus de trois fois la normale, c'est supérieur à 180.

Donc, si j'ai une lipasémie à 200, une lipasémie à 220, une lipasémie à 1000, c'est une pancréasite aiguë. Si j'ai une lipasémie à 100, pour une valeur normale de 60, ce n'est pas une pancréasite aiguë. C'est une petite réaction du pancréas, mais ce n'est pas une pancréasite aiguë.

Donc, pour retenir la pancréasite aiguë, si je vous donne, par exemple, un cas clinique à l'examen, la valeur seuil, si je vous dis qu'on a demandé la lipasémie chez ce patient-là avec une valeur seuil inférieure à 60 unités par litre et que le bilan a retrouvé 220 de lipasémie, vous devez retenir le diagnostic de pancréasite aiguë. Donc, c'est clair, c'est bon. La mylasémie, comme j'ai dit, donc, elle peut être demandée, mais je ne vais pas trop revenir dessus parce qu'elle est quasiment abandonnée, la mylasémie.

Voilà, donc, en total, c'est ça. Vous avez une douleur abdominale aiguë, intense, plus ou moins caractéristique, plus ou moins typique. À côté, vous avez une lipasémie ou une amylasémie supérieur à 3 fois la normale.

Donc, si vous avez ces deux choses, douleur abdominale plus lipasémie supérieur à 3 fois la normale, plus de discussion, vous posez le diagnostic de pancréasite aiguë chez votre patient. Voilà, diagnostic retenu devant cette association typique. Maintenant, question suivante, que faire? J'ai posé le diagnostic.

Oui, c'est bien, bravo. Mais qu'est-ce que je vais faire par la suite? Par la suite, évaluer la gravité, comme on l'a vu au tout début de ce chapitre-là, même à l'introduction, nous avons dit qu'il y a deux grandes familles de pancréasite aiguë. Nous avons la pancréasite aiguë oedémateuse bénigne, qui n'est pas grave, sans aucun problème.

Mais à côté, j'ai certains cas de pancréasite aiguë qui peuvent engager le pronostic vital du patient. Et donc, je dois me poser la question suivante. Comment est-ce que je vais évaluer la gravité de ma pancréasite aiguë? Pour cela, on va s'aider de deux scores, ce qu'on appelle des scores.

Les scores, c'est un tableau, ce sont des critères que je dois rechercher chez mon patient pour évaluer est-ce que ma pancréasite, elle est grave ou est-ce qu'elle est bénigne? Donc, dans ce cas-là, j'ai d'une part un score clinico-biologique de Ronson, qu'on appelle de Ronson, donc sur des critères cliniques et biologiques pour évaluer la gravité de ma pancréasite aiguë. Et à côté, j'ai un score morphologique, score morphologique de Balthazar, qui est basé sur l'imagerie, qui est basé sur la tomодensitométrie ou le scanner. Voilà, score de Ronson.

Alors, score de Ronson se répartit en deux choses. Il faut faire les deux choses successivement. On va faire un bilan initial à l'admission du patient sur cinq critères.

Et puis, je vais refaire un bilan après 48 heures, après avoir hospitalisé le patient. Donc, je dois rechercher d'autres choses après 48 heures. A l'admission, les choses sont simples.

Tout d'abord, je vais rechercher l'âge du patient. Donc, s'il a plus de 55 ans, je lui donne un point de gravité. S'il a des leucocytes, des globules blancs supérieurs à 16 000 éléments par millimètre cube, je lui donne également un point.

Une glycémie supérieure à 11 millimoles, même chose. Une LDH supérieure à 1,5 fois la normale, même chose. Et AZAD supérieur à 6 fois la normale, même chose.

Donc, pour chaque item, je donne un point de gravité à l'admission. Voilà, donc j'ai hospitalisé le patient, je l'ai mis en condition, j'ai commencé à le traiter. Après 48 heures, je refais un deuxième bilan, un bilan qui est plus poussé.

Donc, je vais rechercher la calcémie. Donc, s'il y a une calcémie qui est basse, qui est inférieure à 2 millimoles par litre, je lui donne également un point de gravité. Si j'ai une pression de l'oxygène inférieure à 60 millimètres de mercure, un point également.

Si j'ai une augmentation de l'oreille, des signes d'insuffisance rénale, donc supérieur à 1,8 millimoles par litre, également un point. Si j'ai une baisse de l'hématocrite, supérieur à 10 % par rapport à la normale de l'hématocrite, un point. Si j'ai une baisse de bicarbonate, également un point.

Si j'ai une séquestration liquidienne supérieure à 6 litres, en mesurant les entrées et les sorties du patient, je lui donne un point. Donc, c'est une classification qui est assez complexe, assez rigide quand même. Pour être franc, en pratique quotidienne, c'est une classification qui est rarement utilisée, mais il faut la connaître parce qu'il y a tellement de classifications.

Si vous allez sur Internet et que vous mettez classification Pancrédit aiguë sur Google, vous pourrez avoir facilement une centaine de classifications. Donc, chaque centre hospitalier, chaque pays, quasiment, il a sa classification, il a son score. Et donc, le score de Ronson, c'est l'un des scores les plus utilisés.

Mais il faut avouer que c'est un score qui n'est pas très pratique parce qu'il y a tellement de critères, tellement de choses à rechercher. Le score que nous utilisons, nous, au service le plus souvent, selon notre modeste expérience, c'est ce qu'on appelle le score de Balthazar. Le score de Balthazar, c'est un score qui est basé sur une classification morphologique.

Donc, le patient est hospitalisé et au bout de 48 heures, on fait un scanner abdominale sur le patient. En faisant le scanner abdominale sur le patient, on va évaluer la gravité de la pancréatite et on va la classer en cinq stades morphologiques. Tout d'abord, le stade A, qui correspond à un pancréas qui est normal.

Zéro point pour ce stade là. Le stade B, qui correspond à une augmentation du volume du pancréas. C'est ce qu'on appelle le dents pancréatiques.

Donc, souvent, c'est un pancréas qui est augmenté de taille. Mais comme il y a de l'œdème, c'est bénin. Donc, juste un point.

Le stade C, c'est un stade qui est un peu plus avancé. Donc, on a l'œdème de la grande pancréatique, mais on commence à avoir une infiltration, une inflammation de la graisse péri-pancréatique. Donc, deux points.

Donc, stade A, stade B, stade C. Le stade A, le stade B et le stade C, ce sont des stades qui correspondent à la pancréatite aiguë bénigne, à la pancréatite aiguë oedémateuse. A, B et C. A partir du stade D, nous rentrons dans les choses qui sont graves, dans les choses qui sont sérieuses, parce que dans le stade D, on a ce qu'on appelle une coulée de nécrose, également

appelée collection péri-pancréatique. Donc, coulée de nécrose ou collection péri-pancréatique.

Si j'ai une seule coulée, une seule collection, je parle d'un stade D. Le stade E, c'est le stade ultime, c'est le stade le plus grave. Il correspond à la présence de plusieurs coulées ou plusieurs collections péri-pancréatiques, ou bien à la présence d'une bulle de gaz dans une seule coulée. J'ai une seule coulée pancréatique de nécrose, mais dans la coulée, j'ai des bulles de gaz.

Pourquoi c'est grave ? Pourquoi c'est côté E ? Parce que la bulle de gaz correspond à la prolifération de germes anaérobiques. Donc, ça sous-entend qu'il y a une infection, une surinfection de la coulée de nécrose. Et donc, c'est un stade qui est coté comme stade E, le stade ultime, le stade le plus grave de la pancréatite aiguë.

Quelques images pour illustrer ce que nous venons de dire. Donc, l'image de gauche, le stade A, c'est un pancréas qui est quasiment normal. Le stade B, c'est un pancréas, donc sur l'image de droite, c'est un pancréas qui est augmenté de taille, mais pas plus, c'est un pancréas édémateux, augmenté de taille.

Stade C, image à gauche, sur la tierce positive, donc infiltration et inflammation de la graisse péripancréatique, mais sans coulée de nécrose. Stade D, nous avons déjà une coulée de nécrose qui s'étend un petit peu de la queue du pancréas et qui va en pré-rénale gauche. Donc, stade D, une seule coulée de nécrose.

Et puis, stade E, plusieurs coulées de nécrose. Donc, nous avons un pancréas qui est quasiment détruit. Là, on devine des coulées qui vont quasiment en pré-rénale droite, en pré-rénale gauche, en sous-hépatique.

Donc, stade ultime de la pancréatite aiguë, le stade le plus grave. Bien, juste une petite rubrique, diagnostic différentiel, parce qu'il n'y a pas que la pancréatite aiguë qui peut donner des douleurs épigastriques. Juste pour vous rappeler un petit peu quelles sont les autres douleurs possibles.

Lorsque vous avez un patient qui consulte pour épigastrie aiguë, vous avez, vous pouvez évoquer une crise d'ulcère gastro-duodénal, c'est possible. Vous pouvez également évoquer une gastrite aiguë. Vous pouvez évoquer des pathologies qui sont plus rares, notamment l'infarctus du mésentère, l'abscessus phagocytique.

Une pathologie qui est certes très fréquente, mais à laquelle il faut penser parce que l'infarctus du myocarde peut se manifester par des épigastries dans sa forme abdominale. Et donc, on peut évoquer un infarctus du myocarde lorsque vous avez un patient qui a des épigastries qui sont aiguës. Et puis aussi les péritonites aiguës.

Donc, c'est une petite rubrique, une petite parenthèse que j'ai ouverte pour rajouter le diagnostic différentiel auquel vous devriez penser lorsque vous avez un patient qui consulte pour épigastrie aiguë et que le diagnostic de pancréatite aiguë n'est pas retenu. Alors maintenant,

on reste dans la pancréatite aiguë, dans le diagnostic étiologique. Diagnostic étiologique, c'est une démarche que vous allez suivre pour arriver à une cause à votre pancréatite aiguë.

Donc, vous allez rechercher un faisceau d'arguments qui vont vous orienter vers une cause particulière pouvant expliquer la survenue de la pancréatite aiguë. Donc, vous commencez bien sûr par l'interrogatoire, l'âge du patient. On a vu que souvent, lorsque vous avez une patiente de 30 à 50 ans, on pense déjà à une origine qui est biliaire.

Les antécédents biliaires, si vous avez un patient qui a été opéré pour une pancréa, par exemple pour une lithase vésiculaire ou pour une lithase du colédoque, vous devez penser à la pancréatite aiguë. Si vous avez un patient qui est connu alcoolique, donc il a bu plus qu'un autre jour, il a commencé à avoir des douleurs épigastriques, vous pensez bien sûr à la pancréatite aiguë d'origine alcoolique. Vous recherchez des médicaments, prises médicamenteuses récentes qui peuvent expliquer également la pancréatite aiguë.

Vous recherchez un contexte myotroène particulier, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure. Vous avez un patient qui vient de faire une fibroscopie, un patient qui vient de faire une congé pancréatographie, une syncrotonomie endoscopique. Ces patients-là, s'ils commencent à faire une douleur épigastrique, vous penserez bien sûr à la pancréatite aiguë.

L'état nutritionnel des patients, les patients en surpoids, les patients qui ont des hyperlipidémies, bien sûr, vous penserez à la pancréatite aiguë d'origine lipidique due à la surcharge pondérale. Et puis, les intérêts familiaux, parce qu'il y a des terrains familiaux. Certains patients sur le terrain génétique peuvent avoir des pancréatites aiguës dans un terrain, dans un cadre familial.

Les examens biologiques à retenir, ce sont surtout les examens biologiques qui vont tout d'abord vous orienter vers une cause hépatobiliaire. Donc, vous demanderez un bilan hépatique complet, notamment un dosage des azotés, des alcalins, des gamma-GT, des phosphatase alcalines, la recherche d'un syndrome de cholestase associée, notamment en dosant la bilirubine totale et la bilirubine conjuguée. Et puis, vous complèterez par un bilan général si vous n'avez pas une étiologie qui a été retenue, notamment la recherche d'une hypercalcémie en demandant un bilan phosphocalcique détaillé, la recherche d'une hyperlipidémie en demandant un bilan lipidique et la recherche d'un bilan immunologique perturbé, lorsque vous penserez à une pathologie comme le lupus, par exemple.

Les examens complémentaires, on commence par l'examen le plus simple, le plus anodin, c'est l'échographie hépatobiliaire. Donc, si vous pensez à une pathologie biliaire chez votre patient, vous demanderez une échographie hépatobiliaire et l'échographie hépatobiliaire est souvent suffisante pour retenir ou pour retrouver un calcul de la vésicule biliaire. Maintenant, parfois, vous avez des patients qui ont été cholecystectomisés, des patients qui n'ont plus de vésicule biliaire et là, il faut explorer la veuve principale.

Dans ces cas-là, l'échographie, parfois, n'est pas suffisante parce que vous avez la portion finale,

la portion terminale du canal coelodoc qui passe derrière le pancréas. Et cette portion-là, c'est là où le plus souvent on a des calculs, au fait. Et malheureusement, cette portion-là, elle n'est pas bien explorée par l'échographie parce qu'elle est cachée à la fois par le pancréas et également par le côlon transverse qui passe à ce niveau-là.

Et donc, dans ces cas-là où la veublière n'est pas bien explorée, on peut aller plus loin pour demander une échohondoscopie en deuxième intention. Donc, si l'échographie reste normale, l'échohondoscopie permettra à la fois de faire un geste diagnostique, donc poser le diagnostic d'un éventuel calcul dans la veublière principale, mais également de réaliser un specterotomy endoscopique associé et donc réaliser un geste thérapeutique. Voilà, donc les principales étiologies, comme nous venons de le voir, principales étiologies, c'est la lithiase biliaire.

Dans notre contexte, si je vous pose la question, quelle est la cause la plus fréquente de la pancréasite aiguë au Maroc? C'est la lithiase biliaire. Donc, dans notre contexte, la lithiase biliaire. Le terrain, je ne vais pas revenir sur ce cours-là parce qu'elle a été traitée par le professeur Briot.

Donc, le terrain, c'est le même que pour une lithiase biliaire classique. La pancréasite aiguë, dans ce cas-là, comme je l'ai expliqué, elle est due à la migration d'un calcul qui était initialement dans la vésicule biliaire, qui a migré dans le canal Colédoc. Et puis, de là, il s'est enclavé, il a bouché l'ampoule de Vater vers le bas.

Et en bouchant l'ampoule de Vater, il va provoquer à la fois un blocage de la sécrétion biliaire, mais surtout un blocage de sécrétion pancréatique, qui va faire que les sécrétions pancréatiques vont autodigérer et auto-agresser le pancréas et provoquer la pancréasite aiguë. Et c'est une complication classique des micro-calculs, bien sûr, pas des macro-calculs. Les autres causes, nous allons les passer en revue assez vite.

Donc, nous avons l'alcoolisme. Donc, l'alcoolisme, une pancréasite alcoolique survient quasiment constamment sur un pancréas qui est pathologique après plusieurs années d'intoxication. Donc, c'est un patient qui est connu alcoolique et puis donc qui a fini par développer une pancréasite aiguë.

La pancréasite aiguë peut donc, après une prise d'alcool cocaïne d'alcool, se rendre tout à fait exceptionnelle. Donc, c'est rare où le patient boit de façon intense en une seule fois, il va développer sa pancréasite aiguë. Souvent, c'est un patient qui est connu alcoolique chronique et, comme j'ai dit, va finir par développer une pancréasite aiguë.

La pancréasite post-opératoire, on l'a vu, en matière, donc on a parlé de la pancréasite aiguë iatrogène, donc qui peut être due à l'endoscopie. Elle peut également être due à une chirurgie biliaire. Donc, lorsqu'on fait une chirurgie biliaire, parfois, on est amené à aller traiter un calcul du canal colédoc.

Et donc, dans ces cas-là, on va faire ce qu'on appelle une colédocotomie. On va ouvrir le canal

colédoc. On va mettre une petite sonde.

On va laver le canal colédoc. Et en lavant le canal colédoc, on peut traumatiser l'ampoule de Vater. En traumatisant l'ampoule de Vater, ceci peut provoquer une inflammation de la glande pancréatique.

Également, conjonctivité, on l'a déjà expliqué, donc après sphinctérotomie endoscopique, nous pouvons traumatiser l'ampoule de Vater qui va entraîner une pancréasite aiguë. Et puis, dans certains cas où le traumatisme abdominal est très violent, on peut avoir des traumatismes abdominaux très violents, notamment dans les accidents de la circulation, où on va avoir une contusion, une fracture du pancréas contre le rachis qui va faire que le pancréas va s'inflammer. Et en s'inflammant, ça va provoquer, bien sûr, la pancréasite aiguë post-traumatique.

Et puis, nous avons enfin les pancréasites d'origine médicale. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, juste pour les citer, vous avez les hyper l'hypoprotéinémie, donc les hyperparathyroïdes, les virus, les parasitoses, les infections bactériennes, les vascularites, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment les maladies de Crohn et la RCH.

Donc, c'est une longue liste de pathologies qui peuvent être susceptibles de provoquer une pancréasite aiguë. Mais dans notre contexte, ces causes-là sont rares. Donc, je le répète, la cause biliaire reste la cause prédominante.

Alors maintenant, comment est-ce que peut évoluer une pancréasite aiguë? L'évolution est compliquée. C'est impossible. Là, je reviens toujours à mon schéma initial.

Distinction entre les deux grandes familles, les deux grandes variétés de pancréasites aiguës, les pancréasites aiguës bénignes, quasiment bénignes, donc bénignes, comme le nom l'indique, ce sont des pancréasites qui n'ont pas de complications. Donc, elles sont bénignes, elles vont régresser, elles vont disparaître. À côté, nous avons des pancréasites graves.

Pourquoi? Parce qu'initialement, elles peuvent entraîner des complications d'ordre général métabolique qui peuvent engager le pronostic vital du patient. Et puis, elles sont graves parce que, même si le patient guérit, ils peuvent avoir des séquelles, des complications qui s'enduisent à la grande pancréatique. Et les complications, si on veut quasiment les classer, c'est ça.

Donc, nous avons la surinfection découlée de nécrose. Alors, la surinfection découlée de nécrose, j'ai mis 3-3 dessus. Pourquoi? Parce que c'est la première cause de mortalité en matière de pancréasite aiguë.

Donc, lorsqu'un patient décède d'une pancréasite aiguë, c'est souvent dû à la surinfection découlée de nécrose. Donc, c'est un patient qui développe une pancréasite aiguë grave, stade D ou souvent stade E, avec plusieurs coulées de nécrose. Et puis, une des coulées de nécrose va se surinfecter et en s'en surinfectant, elle va provoquer un choc septique et le choc septique va

emporter le patient.

Donc, c'est la cause la plus fréquente de mortalité. Retenez ça, la cause la plus fréquente de mortalité en matière de pancréasite aiguë, c'est la surinfection découlée de nécrose. Dans l'autre extrême, on a les complications métaboliques.

On l'a cité. Donc, complications métaboliques générales dues au syndrome inflammatoire généralisé, qui est secondaire à la pancréasite aiguë. Donc, complications métaboliques, là aussi, qui peuvent engager le pronostic vital du patient.

Et puis, au milieu, on a les complications qui sont localisées à la grande pancréatique. On a tout d'abord ce qu'on appelle les faux kystes du pancréas. Pourquoi est-ce qu'on les appelle faux kystes? Parce qu'un vrai kyste, il a une paroi qui est propre.

C'est pour ça qu'on l'appelle un kyste. Par rapport à un faux kyste, le faux kyste, c'est une collection qui n'aura pas de paroi propre. Donc, une collection qui va se développer en regard du pancréas.

Mais dans la paroi, elle est formée par l'accrolement des organes de vasinage, dans ce qu'on appelle la fameuse arrière-cavité des épiplans. Si vous avez encore de petits souvenirs d'anatomie, c'est l'occasion de le faire ressortir. La bourse omentale ou arrière-cavité des épiplans, c'est une cavité qui est virtuelle et qui est délimitée, pour rappel, en arrière par la gangue pancréatique et en avant par la face postérieure de l'estomac.

Et dans cette cavité-là, c'est là où les faux kystes du pancréas vont se former. Donc, ce sont des faux kystes qui sont délimités par la gangue pancréatique en arrière et essentiellement par l'estomac en avant et qui peuvent être très, très importants, très volumineux. C'est une complication possible des pancréatides aigus.

On peut avoir ce qu'on appelle un abscondus pancréas. Ce faux kyste-là peut s'infecter. Et donc, en s'infectant, il peut se transformer en abscondus pancréas.

Et on peut aussi avoir des fistules. Donc, cette cavité-là qui va se former va chercher à se vider dans un organe au voisinage. Et donc, ce faux kyste-là peut se fistuliser dans l'estomac.

Donc, c'est ce qu'on appelle une fistule, une communication entre deux organes, donc à travers un tunnel. C'est ce qu'on appelle des fistules. Des images pour illustrer ce qu'on vient d'expliquer.

Ici, nous avons une grosse, grosse image, un faux kyste du pancréas. Donc, vous voyez bien que l'image est hypodense. Elle est bien délimitée.

Elle est bien arrondie. Et vous avez peut-être remarqué une flèche et une étoile. Donc, la flèche correspond à ce qui reste de la grande pancréatique.

Donc, la grande pancréatique, elle a tellement régressé, elle est tellement comprimée par le faux kyste qu'elle a quasiment régressé. La petite étoile correspond à l'estomac. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on a expliqué.

Donc, c'est un faux kyste qui s'est développé dans l'arrière cavité des épiploons, dans la bourse mentale, entre le pancréas en arrière qui est tout petit et l'estomac en avant qui est refoulé, qui est repoussé par cette grande formation qui est le faux kyste du pancréas. Autre illustration, ici, vous avez remarqué des petites hypodensités, des petits points noirs dans la glande pancréatique qui sont montrés par la flèche. Ces petits points noirs montrés par la flèche correspondent à des bulles.

Ce sont des bulles d'air, des bulles de gaz qui sont dues à une surinfection de coulée d'encre rose. Donc, pour poser des diagnostics d'une surinfection de coulée d'encre rose, souvent, on refait le scanner chez ces patients-là et en refaisant le scanner, nous allons voir ces petites bulles de gaz et ces petites bulles de gaz, c'est la surinfection de coulée d'encre rose et c'est malheureusement la première cause possible en matière de pancréatite aiguë. Bien, alors maintenant, dernière question, dernière rubrique, comment traiter une pancréatite aiguë? Le traitement, comme dans pas mal de pathologies, peut être classé en deux grandes catégories, éventuellement une troisième.

Les deux grandes catégories, soit que je vais traiter le symptôme dont souffre le patient, un patient, il a une douleur, donc je traite sa douleur, le patient il vomit, je lui donne des antiémétiques, je traite le symptôme que le patient présente. Également, je peux traiter la cause, ce qu'on appelle un traitement étiologique. Le patient, il a des calculs, il a des calculs qui ont provoqué la pancréatite aiguë, je vais traiter les calculs qui ont provoqué la pancréatite aiguë, ce qu'on appelle un traitement étiologique.

Rajouter à cela un traitement particulier à la pancréatite aiguë, c'est le traitement spécifique aux complications. Donc on a des complications qui sont spécifiques que nous venons de voir, qui sont spécifiques à la pancréatite aiguë, il faut leur proposer un traitement particulier. Donc nous commencerons par le traitement symptomatique.

Traitement symptomatique, retenir un grand réflexe que vous devez avoir lorsque vous pensez, lorsque vous traitez une pancréatite aiguë, c'est le repos digestif. Le repos digestif représente quasiment 60 à 90 % du traitement de pancréatite aiguë. Pardon.

Lorsque vous avez une pancréatite aiguë, il faut mettre au repos le tube digestif. Pourquoi ? Parce que lorsque le patient est âgé, lorsqu'il est au repos digestif, il n'y aura plus de sécrétion pancréatique. Et s'il n'y a plus de sécrétion pancréatique, il n'y aura plus d'inflammation.

Et donc l'inflammation finira par régresser. Et donc le premier réflexe à avoir, c'est de mettre au repos le tube digestif. Donc ça, c'est un.

Deuxième des choses, il faut soulager le pauvre patient. Parce que comme on a dit, le maître symptôme pour lequel le patient a consulté, c'est la douleur. Et donc forcément, le premier réflexe à avoir, il faut soulager la douleur en donnant des antalgiques.

Donc un, vous, bien sûr, vous hospitalisez parce que la pancréatite doit être stadifiée, classée, surveillée. Donc vous hospitalisez le patient. Ça, c'est un.

Deux, vous mettez au repos le tube digestif. Le patient ne mange pas, ne boit pas. Trois, vous lui donnez des antalgiques pour soulager sa douleur.

Et bien sûr, s'il ne mange pas et s'il ne boit pas, il faut lui mettre une perfusion pour ne pas le déshydrater. Et donc on va mettre une perfusion intraveineuse avec des apports hydroélectrolytiques qui sont adaptés pour éviter la déshydratation du patient. Les autres, les deux derniers points, ils sont variables.

La santé nasogastrique, si le patient a des vomissements qui sont très importants, c'est assez rare. Et la réalimentation entérale, si le patient, on n'arrive pas à le réalimenter assez précocement parce qu'on ne peut pas garder le patient à jeun de façon indéfinie. Donc souvent, si le patient est mis à jeun et que la douleur régresse, au bout de 24 à 48 heures, il faut commencer à réalimenter le patient.

On ne va pas torturer le patient, on ne va pas déshydrater le patient, on ne va pas dénourrir le patient. Souvent, lorsque la douleur régresse, au bout de 24 à 48 heures, le patient commence à se réalimenter de façon progressive, de façon progressive. Mais si dans les cas extrêmes, le patient ne s'alimente pas, dans ce cas-là, il faut penser à une réalimentation entérale.

Voilà, donc, autre rubrique, ce sont les pancréatites graves. Les pancréatites graves, ce sont des patients qui seront hospitalisés en réanimation. Pourquoi? Parce que le pronostic vital du patient est mis en jeu.

Donc, forcément, le patient admis en réanimation, pour traiter les défaillances, souvent multiviscérales, dont souffre le patient, qui peut, malheureusement, comme j'ai dit, engager le pronostic vital du patient, il faut penser à une nutrition parentérale, qui sera relayée le plus précocement possible par une nutrition entérale. Mais ça, ça dépendra un peu de l'évolution du patient. Donc, si le patient reste en réanimation, s'il est intubé, s'il est alité, parfois, on peut être amené à le nourrir par une sonde d'alimentation, ce qu'on appelle une jejunostomie d'alimentation ou une sonde nasogéjunale.

Donc, ce sont des patients qui sont assez difficiles, assez délicats à prendre en charge en réanimation. Maintenant, on en a fini avec le traitement symptomatique, on va passer au traitement étiologique. Le traitement étiologique dépendra, bien sûr, de la cause de la pancréatite aiguë.

Comme dans notre contexte, la cause biliaire est la première cause, nous allons commencer par les pancréatites biliaires. Les pancréatites biliaires, les pancréatites, d'abord, oedémateuses ou bénignes, ce sont des patients qui seront hospitalisés au service pour calmer un petit peu l'inflammation, calmer la douleur. Une fois que la douleur est passée, souvent, ce sont des patients qui sont proposés, dans la même hospitalisation, à une cholecystectomie, idéalement, parfois, stéréoscopique.

Donc, pancréatites oedémateuses ou bénignes, pas de discussion, cholecystectomie immédiate dans la même hospitalisation. Ce qui pose problème, ce sont les pancréatites graves, nécrotico-hémorragiques graves. Dans ce cas-là, si elles sont d'origine biliaire, la cholecystectomie est indiquée, mais elle n'est pas faite en urgence.

Pourquoi ? Parce que les patients, même s'il est guéri du stade aigu de la pancréatite, il peut développer secondairement des complications. Et donc, chez ces patients-là, on ne se précipite pas. Donc, ce sont des patients qu'on va traiter calmement, tranquillement, on va refondre la pancréatite aiguë et qui seront revus en consultation pour contrôle.

S'il n'y a pas de complications chez ces patients-là, on peut les proposer pour une cholecystectomie, là aussi, idéalement, par stéréoscopie, et c'est souvent entre la quatrième et la sixième semaine de la guérison, après avoir eu sa pancréatite aiguë. Reste le cas particulier de ce qu'on appelle les nécrosectomies en urgence. Les nécrosectomies en urgence, elles sont indiquées lorsque vous avez une surinfection de la coulée de nécrose, par exemple.

Vous avez beaucoup de nécrose, mais elles sont exceptionnelles. Donc, souvent, lorsqu'on est amené à réaliser des nécrosectomies en urgence, on le prononce qu'il est très, très fâcheux, et donc, la mortalité, elle est très, très élevée. Donc, c'est un geste qui est exceptionnel, mais vous devez le connaître.

La nécrosectomie, elle est possible. Maintenant, lorsqu'on a un calcul associé dans l'infobillière, donc, vous avez la pancréatite aiguë et vous avez un calcul qui a bloqué le canal du versant et qui a bloqué également le canal collédoque et qui a provoqué la pancréatite aiguë. Dans ce cas-là, le traitement idéal, ce serait de faire une sphinctérotomie endoscopique.

Donc, la patiente va avoir une fibroscopie digestive haute. On va traverser l'œsophage, comme j'ai dit, l'estomac duodenum, on arrive au deuxième duodenum. On a un petit crochet avec lequel on va ouvrir le sphincter d'Oddi, et le calcul va passer dans le duodenum et l'obstacle, il est levé.

C'est ce qu'on appelle une sphinctérotomie endoscopique. Si la sphinctérotomie endoscopique n'est pas disponible ou si elle est impossible, dans ce cas-là, on peut aller vers la chirurgie. Je ne vais pas revenir sur le cours qui a été fait par mon ami, professeur Bleriot, par rapport à la chirurgie des voies biliaires.

Pour les autres étiologies, le traitement dépendra, bien sûr, de l'étiologie. Si vous avez un

patient qui est alcoolique, c'est le sévrage alcoolique avec la correction métabolique qui est due au sévrage. Si vous avez une pancréatite médicamenteuse, il faut arrêter les médicaments qui ont provoqué la pancréatite.

Si vous avez une cause métabolique, il faut corriger le désordre métabolique, notamment l'hypercalcémie et les préparatoires chirurgiques. Cela dépendra tout simplement de la cause qui est responsable de la pancréatite aiguë. Maintenant, pour les complications, pour les surinfections des coulées de nécrose, ce sont les antibiotiques, éventuellement le drainage chirurgical, en réalisant ce qu'on a dit tout à l'heure, les nécrosectomies chirurgicales, ou bien des nécrosectomies de drainage qui sont guidées par le scanner, scano-guidée, percutanée, mais là aussi, prenons le cycle extrêmement sombre pour traiter ces surinfections.

Lorsque vous avez un abcès du pancréas, antibiotérapie avec drainage, pour les abcès, donc, antibiotérapie avec drainage, éventuellement avec drainage, les fistules, souvent, c'est la surveillance. Et si la fistule persiste, dans ce cas-là, on peut aller vers la chirurgie. Faut qu'il y ait du pancréas, retenez la règle des 6. Vous n'êtes pas chirurgien, mais retenez cette petite règle qui est très simple à retenir.

La règle des 6, qu'est-ce qu'elle dit, la règle des 6 ? Si j'ai un phoquiste dont le diamètre est supérieur à 6 cm et qui dure plus de 6 semaines, je dois le dériver, d'accord ? Donc, c'est très, très simple. Plus de 6 semaines, plus de 6 cm. Règle des 6, je dois drainer le phoquiste.

Le drainage peut se faire de façon endoscopique ou bien de façon chirurgicale. Je ne vais pas vous encombrer la tête avec les détails, donc vous n'êtes pas censés connaître les détails de la chose, la technicité de la chose si vous êtes en 3e année, mais cette règle des 6 est assez simple à retenir. Voilà, donc on est arrivé au bout de notre chapitre.

En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ce chapitre passionnant des pancréatites aigus ? Première chose et chose la plus importante à retenir, les pancréatites ne se ressemblent pas. Vous avez deux grandes familles au sein des pancréatites aigus. Les pancréatites aigus bénignes, sans problème, sans complication le plus souvent.

Les pancréatites aigus graves, nécrotico-hémorragiques pouvant entraîner le pronostic vital du patient, tuer le patient. Deux grandes familles à retenir, ça c'est un. Deuxième chose dans notre contexte, la cause biliaire est la première étiologie des pancréatites aigus.

C'est pour cela que dans notre contexte, pour faire une petite note de prévention, à chaque fois que vous poserez le diagnostic de lithias biliaire chez vos patients, chez vos futurs patients en tant que praticien, il faut proposer le patient pour une chirurgie, pour un vis-à-vis oculaire. Pourquoi ? Parce que c'est le fait que les patients ne se fassent pas opérer pour leur lithias biliaire qui fait que les calculs migrent et qui fait qu'ils vont faire des enjeux cognitifs des pancréatites aigus. D'accord ? Donc, l'étiologie biliaire est une cause qui est très importante dans notre contexte.

Si vous pensez à une pathologie lithiasique biliaire, adressez vos patients au chirurgien pour régler le problème et prévenir la survenue de complications, parfois très très graves chez nos patients. Autre chose, donc, l'évaluation de la gravité est très importante, c'est ce qu'on a dit dès l'admission du patient. La prise en charge des multidisciplinaires à la fois médicales et chirurgicales, on n'a pas cessé de le répéter, le gastro-entérologue, le réanimateur, le radiologue, le chirurgien, c'est une équipe qui doit traiter la pancréasite aiguë.

Et pour terminer sur une note positive, la prévention, la prévention. Vous êtes des praticiens, vous serez des futurs praticiens. Donc, dernier message à vous faire passer, il vaut mieux prévenir que guérir.

Donc, lithiase biliaire, traiter la lithiase biliaire au stade tout simple de lithiase avant qu'elle ne se fasse une complication qui peut engager son principe vital. Et bien sûr, l'alcoolisme. Si vous avez un patient alcoolique, bien sûr, il faut qu'il arrête de boire pour éviter beaucoup de complications, notamment la pancréasite aiguë.